

WEEKLY REPORT



小編：伊君

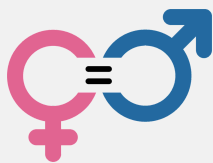
教學部 週戰報

FRIENDLINESS



友善

EQUITY



公平

ARTISTRY



藝術

INSIGHT



洞察

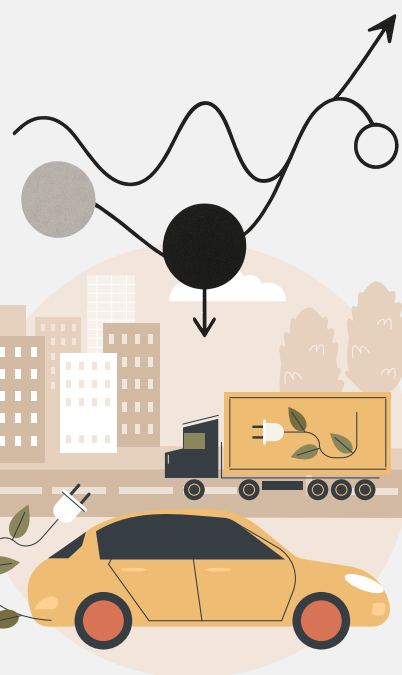
從第一性原理出發，破解線性思維

在推動許多事務的過程中，經常會發現一個隱藏的障礙-線性思維。線性思維的特徵，是傾向用既定流程與過往經驗推導答案，假設因果關係是固定且單向的。然而，在醫療這樣高度複雜且變動的環境中，依賴線性思維，反而可能限制我們看見真正的解方。

破解線性思維的方法之一，就是採用馬斯克推崇的「第一性原理」。這個概念源於物理學，後來被廣泛應用於創新思考與策略制定。它的核心是將問題拆解到最基本、無法再被簡化的事實，再從這些事實重新構建解決方案。當年馬斯克在打造電動車時，團隊篤定地告訴他：「電池太貴了，我們沒辦法壓低成本」一般人面對「電池太貴」的難題時，第一反應往往是繼續尋找更便宜的供應商，或透過談判、併購來壓低成本。但你猜馬斯克做了什麼？他的第一步不是降價談判，而是**直接解散原有的電池團隊，轉而成立一個化學部門。**因為在他看來，**電動車真正需要的不是「電池」，而是「電」本身。**於是，他從原料端重新設計，將鋰、鈷、鎳等元素重新組合成能儲電的裝置，達到同樣甚至更好的發電效果。這個全新製程打造出的「電池」，成本遠低於當時市面上的產品，徹底打破了產業的既定天花板。回到醫院，這意味著我們不能只依循過往的做法，而是先回到最核心的需求與真相。例如，**與其直接沿用以往的醫學教育模式，不如先問：未來人類的核心需求是什麼？現在學習的模式是否能解決未來人的照護模式？**

第一性原理的思維，能幫助我們跳脫慣性與部門框架。例如，當面對急診壅塞的問題時，線性思維可能會直接增加床位或人力；但從第一性原理出發，我們或許會發現真正的瓶頸在於檢查報告的等候時間，或是轉診流程的溝通效率。這種**重新定義問題**的方式，不僅能**更有效地利用資源**，也能帶來**突破性的改善**。

在學習型健康系統的架構中，第一性原理是一種推動持續創新的思考工具。它提醒我們，醫療的進步不只是把舊方法做得更好，而是敢於回到本質、挑戰既有假設，重新建構解方。當醫院每一位成員都能運用這種思維模式，就能在複雜與不確定的情境下，找到最有力的改變途徑，實現「持續學習、持續改善」的願景。



OVERVIEW OF HOME-BASED PRIMARY, GERIATRICS, AND PALLIATIVE CARE PROGRAMS

不同於全民健保制度，美國醫療體系以私人保險為核心，整體醫療支出規模龐大。值得注意的是，醫院照護費用高達總支出的 **31 %**，與僅佔 **3 %** 的居家照護形成強烈對比。居家初級照護（HOUSE CALL SERVICES）旨在病人家中提供類似診所的照護，服務對象多為身體或認知功能受損、難以獨自出門的長者。此服務的優點包括：滿足個體醫療需求、減少住院次數、提升個人與照顧者生活品質，並降低整體醫療成本。



JESSICA LEE, MD

這類照護模式的核心，在於多專業團隊的合作。從醫師、護理師到營養師與社工，每位專業者都扮演關鍵角色，共同面對病人的疾病及整體生活脈絡，包含症狀的變化、家庭支持的強度、居家環境的安全，以及情緒與孤獨感。

LEE醫師團隊將創新科技融入居家照護，透過**虛擬助理設備**（ALEXA ECHO SHOW 8）協助輕度認知障礙的長者在家獲得記憶輔助與社交互動，並推出**居家運動計畫**，結合送餐與運動，讓行動受限者透過動追蹤器（FITBIT）重拾身體活力與人際連結。



AI衝擊醫療前線！

醫療人員，準備好了嗎？

醫學人文課程

人工智慧正迅速進入醫療現場，改變醫病溝通方式。現在，病人手持CHATGPT等生成式AI建議求診已成日常，醫療人員需花更多心力釐清資訊的正確性，避免忽視臨床判斷。

AI除了帶來便利，也引發職場替代、偏見擴大、個資風險與責任歸屬不明等挑戰。專家提醒，AI不一定完整或具實證依據，其承載餵入資料的特定價值與限制；醫療人員可以開放態度回應，同時保持覺察與質疑，善用AI輔助，並守住人文倫理與專業判斷。



陳庭楷社工師主講

個案管理與慢病照護整合實務

在全球慢性病導致 75% 疾病負擔與 80% 死亡率的挑戰下，臺灣雖醫療保健指數領先，但慢性病照護成果仍有落差。要翻轉現況，必須從「疾病導向」轉為「以病人為中心」的目標導向照護。

慢性病照護模式（CCM）強調六大面向：社區資源與政策、健康照護組織、對自我照護的支援、醫療服務體系的設計、醫療決策支援系統及健康資訊系統。



- **社區資源與政策**：從連結現有資源轉為深入理解病人脈絡並倡議建立不足資源。
- **健康照護組織**：從疾病導向轉為跨組織合作，建構以病人目標為核心的照護圈。
- **對自我照護的支援**：從教育病人轉為協助其應對社會文化需求。
- **醫療服務體系的設計**：從急慢性分工轉為彈性設計符合個人價值與偏好的跨專業整合照護。
- **醫療決策支援**：納入生活品質，強調預立醫療計畫與非藥物建議。
- **健康資訊系統**：從提醒/登錄轉為動態記錄病人生活脈絡與價值，並自動分享照護偏好。

個案管理師是推動此模式的關鍵推手，他們能串聯醫療與社區，橋接不同照護場域，協助共同決策，倡議病人目標，並提升自我效能。研究顯示，個案管理可改善症狀、提升資源運用、增進自我管理並具經濟效益。未來須透過專業培訓、制度化角色配置、智慧化資訊系統及「論質計酬」支付，讓個案管理師成為整合照護的總策劃者與以人為本照護的核心力量。

一起出發，一起到達：PGY訓練啟航

在八月初的晨光中，新進PGY醫師魚貫地步入會場，準備迎接職業生涯的第一堂課。



陳志成副院長揭開序幕，直指醫療正在改變：「科技不再是選擇，而是必然。」他娓娓道來奇美醫院的歷史脈絡，更將視野拉向未來，鼓勵新血們在精進專業之餘，勇敢迎接科技浪潮的洗禮。



郭妍伶主任如導航員般，為學員們描繪出「PGY訓練地圖」的每個座標。一年的學習旅程、能力建構的階梯、評量機制的設計，每個環節都透露著醫院對臨床教育的深度思考與殷切期待。

黃博裕醫師以溫和而專業的語調，引領學員們走進奇美AI整合系統的世界。從基礎病歷書寫到AI輔助工具，他將複雜的系統化繁為簡，讓科技成為醫療路上最得力的夥伴。



壓軸登場的廖家德部長，以「一起出發，一起到達」溫暖開場，拋出3個深刻提問：「未來的醫師該學什麼？怎麼學？學來何用？」接著以「為盲人設計手錶」這個看似無關的創意題目，巧妙引導學員重新審視醫師角色，鼓勵他們在醫療專業之外，培養多元思維與創新精神。



重新定義起點

開訓典禮如同醫學路上的啟蒙儀式，不僅是知識的傳授，也賦予心靈的洗禮。從副院長對時代變革的深度洞察，到主任對訓練藍圖的細膩描繪，從醫師對AI系統的實務引導，到部長對創造思維的哲學啟發，每個環節都在告訴這些年輕醫師：在這個AI與醫療深度融合的時代，他們將重新定義什麼是好醫師。期許這些種子們，在接下來的訓練歲月中生根發芽，最終綻放成他們獨特的醫師風采。

同仁專區

破繭而出

CBME白皮書初版綱要諮詢心得

分享者：教學中心宜婷

天還沒亮，細雨伴著，郭妍伶主任、嫵茹與我搭上第一班高鐵北上，一早就到臺大醫院與楊志偉醫師諮詢CBME白皮書的初版架構，臺灣醫學教育學會秘書長同時也是臺灣CBME領域先進的楊醫師對我們的思路給了很大的肯定，接著提出了需多實際的建議：

- ★ 多補充一些背景脈絡，比如目前高齡化社會和醫療科技進步的環境變遷，能讓大家更明白為什麼迫切要推動CBME。
- ★ 核心內容分成幾個重點模組，例如能力架構、課程設計和評量輔導，再用核心要素把它們串起來，讓推動的策略結構更加清晰。
- ★ 有了策略結構，把口號變推動策略也非常重要，例如「以學員為中心」與「數位支持」，要示範如何結合個人學習計畫與數據平台讓學習進展一目了然。
- ★ 建議了實際的推動小技巧，比如怎麼激勵同仁參與、怎麼利用AI幫助老師回饋，以及如何與國際標準接軌。



兩小時的會議後我們帶著滿滿的收穫上了回程高鐵，一邊討論怎麼把這些建議融入書中一邊期待讓它更貼近實務，在未來成為本院推動CBME的依據與指引，幫助教學團隊穩健前行。

相對論之父 - ALBERT EINSTEIN

IF I HAVE ONLY ONE HOUR TO SAVE THE
WORLD, I WOULD SPEND FIFTY FIVE
MINUTES DEFINING THE PROBLEM, AND
ONLY FIVE MINUTES FINDING SOLUTIONS.

如果我有1小時拯救世界，我會花
55分鐘想問題，用5分鐘想解答。